

1. La syncope est une perte transitoire de la conscience associée à une perte du tonus postural.	1. Vrai
2. Les épisodes de syncope sont généralement prédictibles.	2. Faux
3. La syncope est souvent d'origine neuro-cardiogénique chez les adolescents et les jeunes adultes.	3. Vrai
4. Les convulsions sont fréquemment observées lors d'une syncope en cas d'hypotension prolongée.	4. Vrai
5. La syncope peut être déclenchée par une hypersensibilité sino-carotidienne.	5. Vrai
6. Le massage bilatéral du sinus carotidien est un test diagnostique fiable pour les syncopes.	6. Faux
7. La syncope vaso-vagale est souvent déclenchée par la position debout immobile prolongée.	7. Vrai
8. Les prodromes sont caractéristiques de la syncope vaso-vagale.	8. Vrai
9. L'hypertension orthostatique sévère est un facteur de risque de syncope.	9. Vrai
10. Les syncopes arythmiques sont généralement précédées de prodromes.	10. Faux
11. L'ECG est un examen complémentaire essentiel pour le diagnostic des syncopes.	11. Vrai
12. Le Holter du rythme cardiaque peut détecter des arythmies asymptomatiques sans rapport avec la syncope.	12. Vrai
13. Le "tilt-test" est un permet de reproduire la syncope due à une hypotension orthostatique sévère.	13. Faux

14. L'épreuve électrophysiologique est indiquée chez tous les patients présentant une syncope.	14. Faux
15. Le stimulateur cardiaque est recommandé pour traiter les syncopes d'origine neurocardiogénique.	15. Faux
16. Les bas de contention sont conseillés pour les patients souffrant de syncope vaso-vagale.	16. Vrai
17. Les syncopes arythmiques ne nécessitent jamais de traitement.	17. Faux
18. Les syncopes vaso-vagales sont souvent accompagnées de transpirations profuses.	18. Vrai
19. La syncope peut être un symptôme de pathologie cardiaque.	19. Vrai
20. Les syncopes neurocardiogéniques sont rarement associées à des mouvements tonico-cloniques.	20. Vrai
21. Le défibrillateur implantable est recommandé pour toutes les syncopes d'origine indéterminée.	21. Faux
22. Le "tilt-test" peut être réalisé pour confirmer le diagnostic de syncope arythmique.	22. Faux
23. Les syncopes neurologiques sont souvent associées à des signes neurologiques résiduels.	23. Vrai
24. L'hypotension orthostatique est souvent une caractéristique de la syncope neurocardiogénique.	24. Vrai
25. Les syncopes vaso-vagales sont plus fréquentes chez les personnes âgées.	25. Faux
26. Le "tilt-test" est une épreuve électrophysiologique.	26. Faux
27. L'EEG est souvent réalisé pour exclure une épilepsie dans le diagnostic de syncope.	27. Vrai
28. La syncope peut être déclenchée par la peur ou la douleur.	28. Vrai

29. Les syncopes vaso-vagales sont souvent accompagnées de malaises présyncopaux.	29. Vrai
30. Les syncopes arythmiques surviennent généralement sans prodromes.	30. Vrai
31. L'hypotension orthostatique est un signe de syncope arythmique.	31. Faux
32. Les syncopes neurologiques peuvent être provoquées par une crise d'épilepsie avec sommeil post-critique.	32. Vrai
33. Le "tilt-test" est réalisé en position couchée.	33. Faux
34. Le stimulateur cardiaque est toujours efficace dans le traitement des syncopes.	34. Faux
35. Les bas de contention sont recommandés pour les syncopes arythmiques.	35. Faux
36. Les syncopes vaso-vagales sont généralement associées à une pathologie cardiaque.	36. Faux
37. Les syncopes neurologiques sont souvent accompagnées de convulsions.	37. Vrai
38. Le "tilt-test" est un test invasif.	38. Faux
39. Les syncopes vaso-vagales peuvent être déclenchées par la chaleur, la défécation, la toux et la miction.	39. Vrai
40. Les prodromes de la syncope neurocardiogénique peuvent inclure une sensation de chaleur et une pâleur.	40. Vrai
41. Les syncopes neurologiques ne présentent jamais de prodromes.	41. Faux
42. Les syncopes arythmiques peuvent être précédées de palpitations.	42. Vrai
43. Les syncopes arythmiques surviennent souvent après un repas copieux ou post-effort.	43. Faux

44. Les syncopes vaso-vagales surviennent souvent après un long trajet en voiture.	44. Vrai
45. Les syncopes sont des pertes transitoires de conscience avec rémission non spontanée.	45. Faux
46. La syncope est le plus souvent due à une diminution de la perfusion cérébrale due à une diminution du DC.	46. Vrai
47. Les épisodes syncopaux sont rares, transitoires et prévisibles.	47. Faux
48. Le diagnostic étiologique de la syncope est souvent difficile.	48. Vrai
49. Les syncopes arythmiques ou dégénératives surviennent généralement vers 60-70 ans.	49. Vrai
50. Les traumatismes occasionnés par la chute sont un signe de gravité clinique des syncopes.	50. Vrai
51. La perte de conscience est causée par une diminution brutale du flux sanguin cérébral durant 1 à 2 minutes.	51. Faux
52. La perte de conscience est provoquée par une diminution de l'activité de la substance réticulée cérébrale.	52. Vrai
53. L'incontinence urinaire ou fécale fait partie des prodromes de la syncope vaso-vagale.	53. Faux
54. L'origine de la syncope est le plus souvent neurologique.	54. Faux
55. La syncope vaso-vagale représente 80% des cas de syncopes.	55. Faux
56. 30% des cas de syncopes sont dues à une arythmie souvent auriculaire.	56. Faux
57. L'hyperactivité vagale induit une inhibition du tonus vasomoteur et un arrêt du nœud auriculo-ventriculaire lors de la stimulation sino-carotidienne.	57. Faux

58. Une syncope peut être déclenchée par un col serré ou un mouvement de la tête en cas d'hyperactivité vagale.	58. Vrai
59. La syncope due à une hypersensibilité sino-carotidienne peut s'accompagner d'un bloc AV complet.	59. Vrai
60. L'hypersensibilité sino-carotidienne est diagnostiquée par un massage unilatéral du sinus carotidien durant 5 secondes avec un monitoring continu de l'ECG et de la PA (test plus sensible en position couchée).	60. Faux
61. Le massage du sinus carotidien peut provoquer une chute de PA de 50mmHg en cas d'hyperactivité vagale.	61. Vrai
62. La bradycardie sinusale et le bloc AV sont des réponses normales au massage du sinus carotidien.	62. Vrai
63. La réponse cardio-inhibitrice au massage du sinus carotidien est pathologique en cas de pause >1 seconde.	63. Faux
64. La syncope vaso-vagale est induite par une diminution du retour veineux et de la contractilité ventriculaire.	64. Faux
65. La syncope vaso-vagale induit une activation orthosympathique (vasodilatation) et sinusale (bradycardie).	65. Faux
66. L'activation orthosympathique augmente la contractilité ventriculaire avant une syncope vaso-vagale.	66. Vrai
67. Les réactions à l'origine de la syncope vaso-vagale sont provoquées par l'activation de fibres C vasculaires sensibles à la distension et à la pression.	67. Faux
68. La perte de conscience est causée par une diminution brutale du flux sanguin cérébral durant 4-10 secondes.	68. Vrai
69. La déshydratation ou un traitement diurétique excessif peut favoriser les syncopes arythmiques.	69. Faux
70. La nausée et l'assombrissement du champ visuel sont des prodromes de syncopes vaso-vagales.	70. Vrai

71. Lever les jambes du patient permet de rétablir la conscience immédiatement en cas de syncope vaso-vagale.	71. Vrai
72. Les traitement anti-hypertenseurs sont une cause de dysfonction autonome chez le sujet âgé.	72. Vrai
73. L'alcoolisme et le diabète sucré entraînent une dysfonction primaire du système nerveux autonome.	73. Faux
74. Les patients atteints de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson ou de la démence à corps de Lewy sont moins à risque de dysfonction du système nerveux autonome.	74. Faux
75. Les barorécepteurs carotidiens et aortiques et le système orthosympathique luttent contre l'augmentation de la PA lors du passage à la position debout.	75. Faux
76. La syncope de Stockes-Adams est une syncope d'origine neurologique.	76. Faux
77. Les syncopes arythmiques sont associées à une bradycardie ou à une tachycardie ventriculaire.	77. Vrai
78. La durée de la perte de conscience est souvent <60 secondes en cas de syncope vaso-vagale.	78. Vrai
79. Le retour de la conscience est souvent observé en quelques minutes/heures en cas de syncope arythmique.	79. Faux
80. La récupération est plus longue en cas de syncope neurologique.	80. Vrai
81. Les syncopes arythmiques sont rarement associées à des mouvements tonico-cloniques.	81. Faux
82. Les syncopes arythmiques n'ont pas de relation avec la position.	82. Vrai
83. Les syncopes sont de mauvais pronostic en l'absence de pathologie identifiée à l'échographie cardiaque.	83. Faux

84. Le tilt-test est effectué si le patient présente une pathologie cardiaque.	84. Faux
85. Le tilt-test consiste à rester immobile une dizaine de minutes sur un support incliné à 70°.	85. Faux
86. L'isoprotérénol est un bêta-bloquant utilisé pour augmenter la contractilité myocardique pendant le tilt-test.	86. Faux
87. Le tilt-test cherche à reproduire les conditions d'apparition d'une syncope vaso-vagale en augmentant la rétention veineuse au niveau des membres inférieurs et en augmentant la contractilité myocardique.	87. Vrai
88. L'épreuve électrophysiologique nécessite l'introduction d'électrodes par l'artère fémorale en cas de syncope.	88. Faux
89. L'épreuve électrophysiologique détermine la fonction du nœud sinusal, le risque de bloc AV et la propension auriculaire et ventriculaire aux arythmies en cas de syncope.	89. Vrai
90. Un bêta-mimétique par voie orale est administrée durant le tilt-test.	90. Faux
91. Les troubles du rythme reproduisent souvent les symptômes de la syncope à l'épreuve électrophysiologique.	91. Faux
92. Une épreuve électrophysiologique négative est un marqueur de bon pronostic.	92. Vrai
93. La mortalité cardiaque après une épreuve électrophysiologique négative est de 2% par an.	93. Vrai
94. Un défibrillateur implantable est indiqué pour les bradycardies provoquant des syncopes arythmiques.	94. Faux
95. Un défibrillateur implantable est indiqué pour les tachycardies ventriculaires soutenues avec répercussion hémodynamique ou pour les fibrillations ventriculaires provoquant des syncopes arythmiques.	95. Vrai

96. Les patients atteints de syncope vaso-vagale doivent se coucher dès le début des symptômes.	96. Vrai
97. Une hydratation et des apports sodés adéquats sont nécessaires pour éviter les syncopes vaso-vagales.	97. Vrai
98. La bradycardie sinusale est caractérisée par une fréquence cardiaque supérieure à 60 bpm en raison d'une dysfonction du nœud sinusal.	98. Faux
99. Le nœud auriculo-ventriculaire conditionne le rythme cardiaque chez le sujet sain.	99. Faux
100. Le nœud sinusal est vascularisé par une branche de l'artère gauche dans 60% des cas.	100. Faux
101. La fréquence cardiaque de repos est conditionnée par une inhibition vagale permanente du nœud sinusal.	101. Vrai
102. La fréquence cardiaque de repos serait de 120 bpm sans l'inhibition vagale permanente du nœud sinusal.	102. Faux
103. La bradycardie sinusale peut être d'origine intrinsèque ou extrinsèque.	103. Vrai
104. Le remplacement du nœud sinusal par du tissu fibreux est une cause de tachycardie sinusale.	104. Faux
105. Le nœud sinusal est le plus souvent vascularisé par une branche de l'artère coronaire droite.	105. Vrai
106. La bradycardie sinusale est normale et bénigne chez le sportif ou durant le sommeil.	106. Vrai
107. L'hyperthyroïdie, l'hypertension intracrânienne et l'hypothermie sont des causes de bradycardie sinusale.	107. Faux
108. Un tonus vagal accru diminue la fréquence cardiaque par une stimulation du nœud sinusal.	108. Faux
109. La clonidine, les anti-arythmiques et les inotropes négatifs sont parfois responsables de bradycardie.	109. Vrai

110.	La perte de connaissance est provoquée par une asystolie prolongée en cas de syncope vaso-vagale.	110. Vrai
111.	Le patient passe en rythme jonctionnel si la fréquence du nœud sinusal devient inférieure à celle du NAV.	111. Vrai
112.	Le nœud auriculo-ventriculaire a une fréquence d'environ 40bpm.	112. Faux
113.	L'arythmie sinusale bénigne du sportif est une variation cyclique du temps entre 2 ondes P de <10%.	113. Faux
114.	L'arythmie sinusale bénigne du sportif est liée aux variations de la balance ortho- et parasympathique.	114. Vrai
115.	Le temps entre 2 ondes P est accéléré à l'inspiration et ralenti à l'expiration chez le sportif.	115. Vrai
116.	La bradycardie sinusale se manifeste par une augmentation de la durée de l'onde P à l'ECG.	116. Faux
117.	Le bloc sino-auriculaire est caractérisé par une absence de transmission électrique entre l'oreillette et le nœud auriculo-ventriculaire.	117. Faux
118.	L'arrêt sinusal est caractérisé par un arrêt progressif de l'activité électrique sinusale.	118. Faux
119.	La maladie du nœud sinusal coexiste souvent avec des tachycardies atriales (FA ou flutter).	119. Vrai
120.	La prévalence de la maladie du nœud sinusal diminue avec le vieillissement.	120. Faux
121.	La maladie du sinus coexiste souvent avec des altération de la conduction auriculo-ventriculaire.	121. Vrai
122.	Le « syndrome bradycardie-tachycardie » est caractérisé par des accès de tachycardie souvent suivis par de longues pauses sinusales.	122. Vrai

123. La maladie du sinus représente 50% des indications de stimulateur cardiaque.	123. Vrai
124. Le « syndrome bradycardie-tachycardie » provoque des embolies périphériques.	124. Vrai
125. La bradycardie sinusale pathologique est le plus souvent asymptomatique.	125. Faux
126. L'ECG montre un allongement constant du temps de conduction AV dans le bloc AV du premier degré.	126. Vrai
127. L'enregistrement ambulatoire du RC dure toujours 24h en cas de bradycardie sinusale.	127. Faux
128. L'enregistrement ambulatoire du RC permet de rechercher des pauses sinusales symptomatiques de >3s.	128. Vrai
129. Une épreuve d'effort prouve une altération de l'accélération physiologique du rythme cardiaque en cas de bradycardie sinusale.	129. Vrai
130. La prévalence de la maladie du sinus augmente avec le vieillissement.	130. Vrai
131. Le bloc AV du 2 ^{ème} degré de type Mobitz I est caractérisé par un allongement progressif de l'espace PR.	131. Vrai
132. L'épreuve électrophysiologie est réalisée en cas de bradycardie sinusale d'origine extrinsèque.	132. Faux
133. L'épreuve électrophysiologie guide le choix du stimulateur cardiaque en cas de bradycardie sinusale.	133. Vrai
134. Le stimulateur cardiaque possède toujours une sonde auriculaire et une sonde ventriculaire en cas de bradycardie sinusale.	134. Faux
135. Un défibrillateur implantable est indiqué dans le traitement du « syndrome bradycardie-tachycardie ».	135. Faux

136. Les médicaments anti-arythmiques risquent d'aggraver les bradycardies en cas de « syndrome bradycardie-tachycardie » sans stimulateur cardiaque.	136. Vrai
137. Le type Mobitz II du bloc AV du deuxième degré montre une constance dans l'espace PR.	137. Vrai
138. La durée de l'intervalle PR normal est compris entre 0,12 et 0,20 msec pour un RC de 60-100bpm.	138. Faux
139. La propagation de l'influx électrique à travers le NAV est rapide.	139. Faux
140. Le ralentissement de l'influx nerveux au NAV permet aux oreillettes de se contracter avant les ventricules.	140. Vrai
141. Le nœud auriculo-ventriculaire est irrigué par l'artère coronaire droite dans 90% des cas.	141. Vrai
142. La conduction au sein du NAV est ralentie par le système orthosympathique.	142. Faux
143. Le faisceau de His traverse l'anneau fibreux auriculo-ventriculaire puis se divise en 2 branches.	143. Vrai
144. La branche droite du faisceau de His se divise en une branche antérieure et une branche postérieure.	144. Faux
145. Les fibres de Purkinje sont des branches sous-endocardiques diffuses du faisceau de His.	145. Vrai
146. La contraction des ventricules débute à la base du cœur et se dirige vers l'apex.	146. Faux
147. Les blocs AV de type Mobitz I et II accompagnés d'un complexe QRS normal ont un pronostic favorable.	147. Vrai
148. Le type de bloc AV du deuxième degré 2/1 montre une onde P conduite sur 2 au niveau des ventricules.	148. Vrai
149. Le bloc AV du 3 ^{ème} degré se caractérise par une absence de transmission des ondes P aux ventricules.	149. Vrai

150. Les bradycardies sinusales ne nécessitent jamais de traitement.	150. Faux
151. Les ondes P sont toujours normales à l'ECG en cas de bradycardie sinusale.	151. Vrai
152. Le traitement de la bradycardie sinusale extrinsèque est principalement étiologique.	152. Vrai
153. Un stimulateur cardiaque est nécessaire pour les bradycardies sinusales asymptomatiques intrinsèques.	153. Faux
154. Le bloc AV du premier degré est caractérisé par un espace PR < 0,20 secondes.	154. Faux
155. Le BAV du 2 ^{ème} degré de type Mobitz II associé à un bloc de branche risque de progresser rapidement vers un BAV de 3 ^{ème} degré.	155. Vrai
156. Le BAV du troisième degré peut entraîner une mort subite en l'absence de rythme d'échappement.	156. Vrai
157. La dépolarisation septale s'effectue de droite à gauche en cas de bloc de branche gauche.	157. Vrai
158. Dyspnée, fatigue, palpitations, lipothymies et syncopes sont des symptômes de bradycardie sinusale.	158. Vrai
159. Le bloc de branche droit est caractérisé par une onde R large en V1 et une onde S en V6.	159. Faux
160. Le bloc bifasciculaire est une combinaison d'un bloc de branche droit et d'un bloc de branche gauche.	160. Faux
161. Le BAV de type Mobitz I accompagne souvent l'infarctus myocardique inférieur.	161. Vrai
162. Le BAV de type Mobitz II avec QRS fin précède généralement le bloc AV du troisième degré.	162. Faux
163. Les blocs de branche sont plus souvent asymptomatiques chez le sujet âgé.	163. Faux

164. L'étude électrophysiologique, l'ECG et l'enregistrement ambulatoire du rythme cardiaque sont les seuls examens complémentaires nécessaires pour diagnostiquer les BAV et les blocs de branche.	164. Vrai
165. Les blocs AV proximaux ont généralement un meilleur pronostic.	165. Vrai
166. Le traitement des blocs AV peut inclure l'utilisation d'isoprénaline pour accélérer la fréquence cardiaque.	166. Vrai
167. Un stimulateur cardiaque externe temporaire peut être utilisé en attendant la mise en place d'un stimulateur interne permanent pour traiter les blocs AV.	167. Vrai
168. La bradycardie sinusale est toujours symptomatique.	168. Faux
169. Le BAV du 3 ^{ème} degré est accompagné de contractions auriculaires contre une valve tricuspide fermée.	169. Vrai
170. Le bloc de branche gauche se caractérise par une onde R en V1 et une onde S en V6.	170. Faux
171. Le syndrome de Brugada est une cause fréquente de bradycardie sinusale.	171. Faux
172. Le traitement des blocs AV comprend uniquement l'utilisation de médicaments antiarythmiques.	172. Faux
173. Un bloc de branche droit est associé à un segment ST surélevé et décroissant et d'une onde T positive en V1-V2 en cas de syndrome de Brugada.	173. Faux
174. Le traitement des bradyarythmies peut inclure la mise en place d'un stimulateur cardiaque permanent.	174. Vrai
175. Les bradyarythmies peuvent être causées par une hypothyroïdie.	175. Vrai

176.	Le bloc de branche droit est associé à un axe du complexe QRS dévié vers la droite.	176. Faux
177.	Le syndrome bradycardie-tachycardie est souvent associé à la maladie du nœud sinusal.	177. Vrai
178.	Le bloc AV du deuxième degré de type Mobitz I est caractérisé par une constance dans l'espace PR.	178. Faux
179.	Le bloc AV du deuxième degré de type Mobitz II est caractérisé par un allongement progressif du PR.	179. Faux
180.	Le traitement des bradyarythmies peut comprendre l'utilisation de médicaments anti-inflammatoires.	180. Faux
181.	Le syndrome de Brugada est une cause génétique rare de mort subite.	181. Vrai
182.	Le bloc AV du 1 ^{er} degré est toujours situé dans le nœud auriculo-ventriculaire.	182. Faux
183.	Le BAV du 1 ^{er} degré est caractérisé par un allongement de la conduction entre l'oreillette et le ventricule.	183. Vrai
184.	L'intervalle PR est supérieur à 200ms en cas de bloc AV du 1 ^{er} degré.	184. Vrai
185.	Le nœud auriculo-ventriculaire est le plus souvent vascularisé par l'artère interventriculaire antérieure.	185. Faux
186.	Les branches du faisceau de His sont isolées électriquement du myocarde.	186. Vrai
187.	L'ischémie, la sarcoïdose et les traumatismes chirurgicaux peuvent altérer le tissu de conduction.	187. Vrai
188.	Le BAV du 2 ^{ème} degré est caractérisé par une absence de conduction des ondes P aux ventricules.	188. Faux
189.	Le BAV du 2 ^{ème} degré est caractérisé par une alternance d'ondes P conduites et non-conduites aux ventricules en présence d'un rythme sinusal irrégulier.	189. Faux

190. La tachycardie peut être déclenchée par une hyperthyroïdie.	190. Vrai
191. Le BAV de 3 ^{ème} degré de type Mobitz I est caractérisée par une altération stéréotypée et répétée de la conduction auriculo-ventriculaire.	191. Faux
192. Toutes les ondes P sont conduites avec retard en cas de BAV de 2 ^{ème} degré de type Mobitz I.	192. Faux
193. Si le BAV est associé à un bloc de branche, le bloc de conduction est situé dans le système His-Purkinje.	193. Vrai
194. Si le BAV de 2 ^{ème} degré est accompagné d'un QRS normal, le bloc de conduction est situé dans le NAV et est plus susceptible de progresser rapidement vers un BAV de 3 ^{ème} degré.	194. Faux
195. On parle de BAV de 2 ^{ème} degré de type « haut degré » si plusieurs ondes P d'affilée sont bloquées.	195. Vrai
196. Les ondes P ne sont jamais transmises aux ventricules en cas de BAV du 3 ^{ème} degré.	196. Vrai
197. Le rythme de contraction des oreillettes est plus lent que celui des ventricules en cas de BAV complet.	197. Faux
198. Les ventricules se contractent indépendamment des oreillettes en cas de BAV du 2 ^{ème} degré.	198. Faux
199. Le bloc AV de type Mobitz II peut être associé à une intoxication médicamenteuse.	199. Faux
200. La durée normale du complexe QRS est <0,10 secondes.	200. Vrai
201. La durée du QRS est >0,12 secondes en cas de bloc de branche majeur.	201. Vrai
202. Le bloc de branche droit est caractérisé par une disparition des ondes R en V1 et des ondes Q en V6.	202. Faux

203.	L'axe du complexe QRS est situé entre 0° et -30° en cas de bloc de branche gauche.	203. Faux
204.	Le bloc de branche gauche se manifeste par une onde Q large en V1 et une onde R large en V6 à l'ECG.	204. Vrai
205.	La durée normale du complexe QRS est comprise entre 0,12 et 0,20 secondes.	205. Faux
206.	Le segment ST et l'onde T sont en opposition avec le signe du QRS en cas de bloc de branche gauche.	206. Vrai
207.	Un bloc de branche gauche mineur est caractérisé par une durée du complexe QRS entre 0,10 et 0,12 secondes et une dépolarisation septale normale.	207. Vrai
208.	La dépolarisation septale normale s'effectue de la droite vers la gauche.	208. Faux
209.	Les ondes R en V1 et Q en V6 sont normales en cas de bloc de branche droit.	209. Vrai
210.	Le bloc de branche droit est caractérisée par un RSR' en V6 à l'ECG.	210. Faux
211.	L'axe du complexe QRS reste normal en cas de bloc de branche droit.	211. Vrai
212.	Les ondes T sont négatives en V1 et V2 en cas de bloc de branche droit.	212. Vrai
213.	Le bloc de branche gauche est caractérisée par un RSR' en V1 à l'ECG.	213. Faux
214.	Les complexes QRS ne sont pas élargis en cas d'hémibloc gauche.	214. Vrai
215.	Le bloc bifasciculaire est parfois associé à un bloc AV du 1 ^{er} degré.	215. Vrai
216.	L'axe du complexe QRS est fortement dévié vers la droite en cas d'hémibloc antérieur gauche.	216. Faux

217. La durée du QRS est <0,10 secondes en cas d'hémibloc antérieur gauche.	217. Vrai
218. L'axe du complexe QRS est situé entre -45° et -90° en cas d'hémibloc antérieur gauche.	218. Vrai
219. La transition précordiale est déplacée vers la droite en cas d'hémibloc antérieur gauche.	219. Faux
220. La transition précordiale correspond à la dérivation où l'onde R devient une onde S.	220. Vrai
221. L'axe du complexe QRS est dévié vers la droite en cas d'hémibloc postérieur gauche.	221. Vrai
222. L'axe du complexe QRS est généralement situé entre +90° et +120° en cas d'hémibloc postérieur gauche.	222. Faux
223. La durée du QRS est >0,12 secondes en cas d'hémibloc postérieur gauche.	223. Faux
224. Les blocs AV et les blocs de branche sont généralement plus symptomatiques chez le sujet âgé sédentaire.	224. Vrai
225. Le BAV de type Mobitz II avec QRS large précède la syncope de Stokes-Adams.	225. Vrai
226. Le BAV de 3 ^{ème} degré est associé à une disparition du B1 à l'auscultation cardiaque.	226. Faux
227. Le BAV de 3 ^{ème} degré est associé à des « ondes de canons » au niveau du pouls jugulaire.	227. Vrai
228. Le degré d'ouverture de la valve mitrale au moment de la systole est variable en cas de BAV du 3 ^{ème} degré.	228. Vrai
229. Un bloc de branche gauche associé à un segment ST surélevé et décroissant et d'une onde T négative en V1-V2 doit faire suspecter un syndrome de Brugada.	229. Faux
230. Le syndrome de Brugada est causé par une mutation du gène codant pour le canal Na ⁺ .	230. Vrai

231. Il faut exclure toute cause toxique avant de traiter un BAV ou un bloc de branche.	231. Vrai
232. L'isoprénaline est un bêta-mimétique utilisé pour réduire la fréquence cardiaque en cas de BAV.	232. Faux
233. Le stimulateur cardiaque externe temporaire est constitué d'une sonde dans le ventricule gauche apporté par abord veineux fémoral ou jugulaire.	233. Faux
234. Le stimulateur interne permanent n'est jamais indiqué en cas de BAV du 2 ^{ème} degré.	234. Faux
235. Les troubles de la conduction auriculo-ventriculaire et intra-ventriculaire se manifestent par de la dyspnée, des lipothymies et des syncopes.	235. Vrai
236. Le stimulateur interne permanent est indiqué pour les BAV asymptomatiques du 3 ^{ème} degré.	236. Vrai
237. Le stimulateur interne permanent est indiqué pour tous les BAV symptomatiques.	237. Vrai
238. Les arythmies supra-ventriculaires sont toujours associées à une altération de la fonction ventriculaire.	238. Faux
239. La tachycardie jonctionnelle peut être traitée avec succès par des manœuvres vagales.	239. Vrai
240. L'électrocardiogramme dans le syndrome de pré-excitation montre toujours une onde delta bien visible.	240. Faux
241. La tachycardie sinusale peut être causée par une hyperthyroïdie.	241. Vrai
242. La voie accessoire est mieux visualisée à l'ECG lorsqu'elle est située dans la région latérale gauche.	242. Faux
243. La tachycardie sinusale est parfois traitée par des médicaments bêta-bloquants.	243. Vrai

244.	Les arythmies supra-ventriculaires sont toujours associées à des pathologies cardiovasculaires.	244. Faux
245.	La tachycardie antidromique est caractérisée par une onde delta visible à l'ECG.	245. Vrai
246.	La voie accessoire se détériore généralement avec l'âge en cas de syndrome de pré-excitation.	246. Vrai
247.	La tachycardie jonctionnelle peut être déclenchée par des émotions.	247. Vrai
248.	L'électrocardiogramme dans le syndrome de pré-excitation montre toujours une tachycardie ventriculaire.	248. Faux
249.	L'ablation par radiofréquence est une option de traitement pour la tachycardie jonctionnelle.	249. Vrai
250.	La tachycardie jonctionnelle se manifeste par des palpitations régulières et rapides et une polyurie.	250. Vrai
251.	La tachycardie jonctionnelle peut être déclenchée par des manœuvres qui augmentent l'activité vagale.	251. Faux
252.	La pyrexie et l'effort physique sont des causes physiologiques de tachycardie sinusale.	252. Vrai
253.	Les palpitations associées à la tachycardie jonctionnelle sont rapides et irrégulières.	253. Faux
254.	Les accès de tachycardie jonctionnelle peuvent être ralentis par une respiration profonde.	254. Vrai
255.	Le syndrome de pré-excitation est généralement asymptomatique et découvert par hasard à l'ECG.	255. Vrai
256.	La tachycardie jonctionnelle affecte principalement les enfants.	256. Faux
257.	L'adénosine IV ralentit la conduction auriculo-ventriculaire presque immédiatement.	257. Vrai
258.	La tachycardie sinusale est caractérisée par un rythme cardiaque >120bpm avec des ondes P normales.	258. Faux

259. Une insuffisance cardiaque ou pulmonaire, une embolie pulmonaire ou un infarctus myocardique peuvent provoquer une tachycardie sinusale.	259. Vrai
260. La caféine, la théophylline, l'atropine et les bêta-bloquants peuvent provoquer une tachycardie sinusale.	260. Faux
261. L'hypovolémie et l'anémie augmentent la fréquence cardiaque.	261. Vrai
262. Le traitement de l'asthme peut parfois provoquer une tachycardie sinusale.	262. Vrai
263. Les complexes QRS sont élargis à l'ECG en cas de tachycardie sinusale.	263. Faux
264. Le traitement de la tachycardie sinusale est essentiellement étiologique.	264. Vrai
265. La maladie de Bouveret est une tachycardie jonctionnelle par réentrée via un faisceau accessoire.	265. Faux
266. Le circuit de réentrée tourne dans le NAV dans la maladie de Bouveret.	266. Vrai
267. Le circuit de réentrée est caractérisé par une voie lente à période réfractaire longue et une voie rapide à période réfractaire courte en cas de maladie de Bouveret.	267. Faux
268. La tachycardie paroxystique supra-ventriculaire est aussi appelée syndrome de Wolff-Parkinson-White.	268. Faux
269. L'influx électrique passe d'abord par la voie rapide et remonte vers l'oreillette par la voie lente dans la forme typique de la tachycardie jonctionnelle par réentrée intranodale.	269. Faux
270. Une onde P rétrograde est toujours observée à l'ECG en cas de maladie de Bouveret.	270. Faux

271. L'influx électrique passe d'abord par la voie lente et remonte vers l'oreillette par la voie rapide dans la forme typique de la tachycardie jonctionnelle par réentrée intranodale.	271. Vrai
272. L'onde P rétrograde est parfois masquée par le QRS dans la forme typique de la maladie de Bouveret.	272. Vrai
273. L'ECG peut distinguer la maladie de Bouveret et un syndrome de pré-excitation pendant la tachycardie.	273. Faux
274. Une onde P rétrograde est parfois observée avant le QRS dans la forme typique de la TPSV.	274. Faux
275. Une onde P rétrograde négative est bien visible en D2, aVF, D3 et V6 dans la forme atypique de la TPSV.	275. Vrai
276. Une onde P rétrograde négative est visible en V1 dans la forme atypique de la TPSV.	276. Faux
277. Une onde P rétrograde est présente en rythme sinusal en cas de maladie de Bouveret.	277. Faux
278. La tachycardie paroxystique supra-ventriculaire est déclenchée par une extrasystole auriculaire.	278. Vrai
279. L'extrasystole auriculaire ne déclenche un accès de tachycardie paroxystique supra-ventriculaire que si elle survient lors de la période réfractaire de la voie lente.	279. Faux
280. L'extrasystole auriculaire ne déclenche un accès de TPSV que si le temps de conduction de la voie lente est assez long pour que la voie rapide soit sortie de sa période réfractaire et prête à conduire l'influx nerveux.	280. Vrai
281. L'extrasystole auriculaire induit une dépolarisation de la voie lente à période réfractaire courte.	281. Vrai
282. Le faisceau de Kent est un faisceau électrique anormal entre le NAV et le ventricule.	282. Faux

283.	Le faisceau de Kent équivaut à la voie rapide à période réfractaire courte de la maladie de Bouveret.	283. Faux
284.	Le faisceau de Kent ne participe pas à la dépolarisation du ventricule en dehors des accès de tachycardie.	284. Faux
285.	L'influx électrique est plus rapide à travers le faisceau de Kent qu'à travers le NAV en cas WPW.	285. Vrai
286.	La voie accessoire dépolarise une partie du ventricule avant le NAV en cas de syndrome de pré-excitation.	286. Vrai
287.	Les connexions électriques anormales autres que le faisceau de Kent représente 10% des cas de WPW.	287. Faux
288.	Le syndrome de Lown-Gonong-Levine est caractérisé par une voie atrio-nodale avec un PR court à l'ECG.	288. Vrai
289.	Le faisceau de Manheim est composé de fibres nodo-ventriculaires.	289. Vrai
290.	L'accès de tachycardie orthodromique est déclenché par une extra-systole auriculaire qui descend uniquement par le NAV en cas de syndrome de Wolff-Parkinson-White.	290. Vrai
291.	L'accès de tachycardie peut être déclenché par une extra-systole ventriculaire en cas de WPW.	291. Vrai
292.	La tachycardie antidromique est la plus commune en cas de syndrome de Wolff-Parkinson-White.	292. Faux
293.	La tachycardie orthodromique est caractérisée par un influx rétrograde par le faisceau de His et le NAV.	293. Faux
294.	La tachycardie antidromique est caractérisée par un influx rétrograde par le faisceau accessoire anormal.	294. Faux
295.	La tachycardie antidromique est plus rare en cas de syndrome de pré-excitation.	295. Vrai
296.	L'ECG ne permet pas de distinguer la maladie de Bouveret et un syndrome de pré-excitation au repos.	296. Faux

297. Les extrasystoles sont parfois décrites comme une impression de battement manquant.	297. Vrai
298. Le remplissage diastolique et le volume éjecté systolique sont augmentés lors d'une extrasystole.	298. Faux
299. Les extrasystoles qui dépolarisent le nœud sinusal donne une sensation de pression thoracique.	299. Vrai
300. Une extrasystole ventriculaire peut dépolariser le nœud sinusal par conduction rétrograde.	300. Vrai
301. La diastole qui suit une extrasystole ayant dépolarisé le nœud sinusal est allongée.	301. Vrai
302. Le volume éjecté systolique après une extrasystole ayant dépolarisé le nœud sinusal est diminué.	302. Faux
303. Le premier épisode de TPSV ou de WPW survient toujours à l'âge adulte.	303. Faux
304. La tachycardie est décrite comme des accès de palpitations de durée fixe en cas de TPSV ou de WPW.	304. Faux
305. Les accès de tachycardie peuvent être accompagnés de malaises lipothymiques, d'un état présyncopal ou de syncopes en cas de TPSV ou de WPW.	305. Vrai
306. La tachycardie jonctionnelle par réentrée intranodale affecte généralement des sujets d'âge moyen.	306. Vrai
307. Les patients atteints de tachycardie jonctionnelle ont souvent une pathologie cardiaque sous-jacente.	307. Faux
308. L'origine jonctionnelle de la tachycardie est suspectée si les palpitations sont accélérées par des manœuvres qui augmentent l'activité vagale.	308. Faux
309. Se mettre de l'eau glacée sur le visage permet de ralentir ou de stopper la tachycardie jonctionnelle.	309. Vrai

310. Les palpitations régulières et rapides sont accompagnés d'oligourie en cas de tachycardie jonctionnelle.	310. Faux
311. Les contractions auriculaires contre une valve mitrale fermée entraîne des « ondes de canon » dans les veines jugulaires ressenties comme une pulsatilité au niveau du cou en cas de tachycardie jonctionnelle.	311. Faux
312. La tachycardie jonctionnelle a un début et une fin brutale.	312. Vrai
313. La tachycardie sinusale est caractérisée par des QRS larges à l'ECG.	313. Faux
314. Les accès de tachycardie jonctionnelle sont favorisés par l'exercice, la caféine, la cigarette et l'alcool.	314. Vrai
315. Le syndrome de Wolff-Parkinson-White est très souvent symptomatique.	315. Faux
316. La tachycardie par réentrée orthodromique est impossible dans la majorité des voies accessoires.	316. Faux
317. Moins de 10% des voies accessoires ne sont pas capables de conduction rétrograde.	317. Vrai
318. Les palpitations sont toujours dues au Wolff-Parkinson-White chez les patients avec une voie accessoire.	318. Faux
319. La tachycardie jonctionnelle a un début brutal et une fin progressive.	319. Faux
320. Certaines voies accessoires ne sont pas capables de conduire l'influx de l'oreillette vers le ventricule.	320. Vrai
321. Moins de 50% des voies accessoires sont uniquement capables de conduction rétrograde.	321. Vrai
322. Une onde delta est visible en rythme sinusal si la voie accessoire ne fait que la conduction rétrograde.	322. Faux
323. La tachycardie orthodromique est impossible si la voie accessoire ne fait que la conduction rétrograde.	323. Faux

324. Les patients qui présentent une voie accessoire ont généralement moins de 50 ans.	324. Vrai
325. La voie accessoire se développe souvent avec l'âge.	325. Faux
326. Les accès de palpitations surviennent sans cause favorisante évidente en cas de Wolff-Parkinson-White.	326. Vrai
327. Les accès de palpitations sont très dépendants des variations du système nerveux autonome en cas de syndrome de pré-excitation.	327. Faux
328. Le taux de succès des manœuvres vagales est plus élevé dans le WFW que dans la TPSV.	328. Vrai
329. L'arythmie peut persister pendant plusieurs heures en cas de syndrome de pré-excitation.	329. Vrai
330. L'arrêt de l'arythmie peut nécessiter un traitement IV ou une cardioversion externe en cas de WPW.	330. Vrai
331. Une tachycardie persistante pendant plusieurs mois/années induit une tachycardiomyopathie dilatée irréversible après l'arrêt du trouble du rythme en cas de WPW.	331. Faux
332. La moitié des patients atteints de WPW présentent des accès de fibrillation auriculaire paroxystique.	332. Vrai
333. Les traitements inhibant le NAV sont recommandés en cas de WPW associé à une FA.	333. Faux
334. Les digitaliques, le vérapamil, le diltiazem, les manœuvres vagales, l'adénosine et l'amiodarone bloquent plus le NAV que la voie accessoire en cas de syndrome de pré-excitation.	334. Vrai
335. La FA provoquée par le WPW peut exceptionnellement induire une FV et une mort subite.	335. Vrai

336.	La mort subite est précipitée par les médicaments qui bloquent moins le NAV que la voie accessoire.	336. Faux
337.	La cardioversion électrique externe est le traitement de 1 ^{er} choix pour tous les cas de WPW + FA.	337. Faux
338.	La procainamide IV est indiquée chez le patient stable atteint de WPW + FA.	338. Vrai
339.	La cardioversion électrique externe doit être effectuée en cas de WPW + FA instable.	339. Vrai
340.	L'ECG est anormal en dehors des accès de tachycardie jonctionnelle dans la maladie de Bouveret.	340. Faux
341.	Les formes typiques de TPSV sont caractérisées par un intervalle PR long et un intervalle RP court.	341. Vrai
342.	L'axe électrique de l'onde P est négatif dans les dérivations frontales (D2, D3 et aVR) en cas de TPSV.	342. Faux
343.	L'onde P rétrograde est souvent cachée au sein du complexe QRS en cas de tachycardie jonctionnelle.	343. Vrai
344.	L'onde P rétrograde est à peine visible sous la forme d'une onde S en D2 et ou r' en V1 en cas de TPSV.	344. Vrai
345.	Une onde P rétrograde positive est souvent observée en D2, D3 et aVF dans la maladie de Bouveret.	345. Faux
346.	Les formes atypiques de TPSV sont caractérisées par un intervalle PR court et un intervalle RP long.	346. Vrai
347.	Les complexes QRS sont larges dans les formes typiques de la maladie de Bouveret.	347. Faux
348.	La dépolarisation ventriculaire s'effectue par le faisceau de His dans les formes typiques de TPSV.	348. Vrai
349.	L'ECG est normal en dehors des accès de tachycardie jonctionnelle dans le syndrome de pré-excitation.	349. Faux
350.	Le syndrome de pré-excitation est caractérisé par un intervalle PR court à l'ECG.	350. Vrai

351. L'intervalle PR normal est compris entre 0,12 et 0,20 secondes.	351. Vrai
352. L'onde delta est d'autant moins visible que la voie accessoire est située proche du NAV.	352. Faux
353. Les voies accessoires droites ou septales sont mieux visualisées à l'ECG en cas de WPW.	353. Vrai
354. Un traitement par digitaliques augmente l'onde delta à l'ECG en cas de syndrome de pré-excitation.	354. Vrai
355. L'onde delta est plus grande si le faisceau accessoire est activée tardivement après le NAV.	355. Faux
356. L'inhibition de la conduction AV favorise la dépolarisation ventriculaire par le faisceau accessoire et aggrave la pré-excitation.	356. Vrai
357. L'augmentation de la conduction du NAV augmente l'onde delta à l'ECG en cas de WPW.	357. Faux
358. L'onde delta disparaît durant la tachycardie orthodromique en cas de Wolff-Parkinson-White.	358. Vrai
359. L'onde delta est observée juste après le QRS en rythme sinusal en cas de Wolff-Parkinson-White.	359. Faux
360. Les complexes QRS sont normaux pendant la tachycardie orthodromique en cas de WPW.	360. Vrai
361. La fréquence ventriculaire varie entre 180 et 250bpm dans le Wolff-Parkinson-White.	361. Vrai
362. L'intervalle PR est plus long que l'intervalle RP en cas de syndrome de pré-excitation.	362. Vrai
363. La fréquence ventriculaire dépend de la vitesse de conduction à travers la voie accessoire en cas de WPW.	363. Faux
364. Une onde P rétrograde est visible dans le segment ST après le QRS en cas de tachycardie orthodromique.	364. Vrai

365. Les QRS sont très élargis en cas de tachycardie antidromique car la dépolarisation n'emprunte pas le système de conduction spécialisé intra-ventriculaire.	365. Vrai
366. Les études électrophysiologiques précisent le mécanismes de la tachycardie en cas TPSV ou de WPW.	366. Vrai
367. Les études électrophysiologiques ne précisent pas le site de la tachycardie en cas de TPSV ou de WPW.	367. Faux
368. Certains cas de TPSV ou de WPW ne nécessitent pas de traitement.	368. Vrai
369. L'ablation du circuit de réentrée par radiofréquence se fait via un cathéter inséré dans l'artère fémorale.	369. Faux
370. L'abstention thérapeutique est la meilleure option en cas de TPSV ou de WPW si les accès sont rares et spontanément résolutifs.	370. Vrai
371. Le traitement curatif invasif est très efficace pour traiter la tachycardie jonctionnelle et le WPW.	371. Vrai
372. Eviter les excitants permet de diminuer le nombre d'accès de tachycardie jonctionnelle.	372. Vrai
373. Les cas de TPSV ou de WPW hémodynamiquement instable nécessite une CEE immédiate.	373. Vrai
374. L'hémodynamique instable est définie par une pression artérielle <120/80 mmHg.	374. Faux
375. Les cas de TPSV ou de WPW sont le plus souvent hémodynamiquement instables lors de la tachycardie.	375. Faux
376. Les manœuvres vagales doivent être évitées pour les cas de TPSV ou de WPW atteints de FA.	376. Vrai
377. La tachycardie jonctionnelle et la tachycardie antidromique sont caractérisées par des QRS fins à l'ECG.	377. Faux

378.	Les manœuvres vagales permettent d'augmenter la période réfractaire et le temps de conduction du NAV.	378. Vrai
379.	Une compression douce de 5-10sec du sinus carotidien peut être réalisée en cas de souffle carotidien.	379. Faux
380.	Les manœuvres vagales sont plus efficaces pour arrêter une tachycardie jonctionnelle qu'un WPW.	380. Faux
381.	La compression simultanée des 2 sinus carotidiens permet de calmer les accès de tachycardie du WPW.	381. Faux
382.	La manœuvre de Valsalva est réalisée en cas d'échec des manœuvres vagales.	382. Vrai
383.	Un traitement per os par adénosine permet de ralentir la conduction AV pendant quelques secondes.	383. Faux
384.	L'adénosine est contre-indiquée pour traiter la tachycardie à complexes larges antidromiques.	384. Faux
385.	L'adénosine provoque un bloc AV transitoire qui termine la tachycardie en cas de TPSV ou de WPW.	385. Vrai
386.	L'adénosine agit sur les récepteurs adrénergiques α_1 cardiaques.	386. Faux
387.	La dyspnée, le flush facial et la douleur thoracique rapportée sont des effets secondaires de l'adénosine IV.	387. Vrai
388.	L'adénosine n'est pas un traitement risqué pour les patients asthmatiques.	388. Faux
389.	L'adénosine peut accélérer une tachyarythmie pré-excitée et provoquer une bronchoconstriction.	389. Vrai
390.	La cardioversion électrique externe est le traitement aigu de dernier recours pour la TPSV et le WPW.	390. Vrai
391.	L'esmolol IV est un bêta-mimétique à courte durée d'action utilisé pour traiter la TPSV et le WPW en aigu.	391. Faux
392.	L'esmolol peut être administré si le patient a un traitement oral chronique par anticalciques.	392. Faux

393.	L'esmolol est réservé aux cas hémodynamiquement stable sans insuffisance cardiaque décompensée.	393. Vrai
394.	Le vérapamil ou le diltiazem IV peuvent être administrés en cas de tachycardie ventriculaire.	394. Faux
395.	Le vérapamil ou le diltiazem IV sont contre-indiqués en cas de FA avec pré-excitation.	395. Vrai
396.	Le vérapamil IV peut être administré si le patient a un traitement oral chronique par bêta-bloquants.	396. Faux
397.	Le vérapamil ou le diltiazem IV sont réservés aux cas hémodynamiquement stable avec FEVG <40%.	397. Faux
398.	La manœuvre de Valsalva est le traitement de 1 ^{ère} intention de la tachycardie jonctionnelle ou du WPW.	398. Faux
399.	L'esmolol, le vérapamil et le diltiazem ne sont utilisés qu'en cas d'échec du traitement par adénosine.	399. Vrai
400.	L'ablation du circuit de réentrée par radiofréquence présente un haut risque de complications.	400. Faux
401.	La mortalité associée à l'ablation du circuit de réentrée par radiofréquence est de 1/1000.	401. Vrai
402.	L'ablation du circuit de réentrée par radiofréquence entraîne un bloc AV dans 1% des cas.	402. Vrai
403.	L'ablation du circuit de réentrée par radiofréquence n'entraîne jamais une tamponnade.	403. Faux
404.	L'ablation du circuit de réentrée nécessite l'introduction de cathéters dans les cavités cardiaques droites et dans le sinus coronaire.	404. Vrai
405.	La voie rapide est éliminée par radiofréquence pour traiter la tachycardie jonctionnelle.	405. Faux
406.	Le faisceau accessoire est éliminé par radiofréquence pour traiter le syndrome de pré-excitation.	406. Vrai

407.	Le diltiazem ou le vérapamil remplace l'ablation par radiofréquence si le patient refuse l'intervention.	407. Vrai
408.	Si la voie accessoire conduit lentement, elle ne doit pas être enlevée par radiofréquence.	408. Vrai
409.	Le traitement médicamenteux est préféré à l'ablation en cas de tachycardie antidromique.	409. Faux
410.	Le traitement médicamenteux est préféré à l'ablation si le patient pratique un métier à risque.	410. Faux
411.	Le traitement par diltiazem ou vérapamil est préféré à l'ablation en l'absence de FA pré-excitée.	411. Vrai
412.	Le vérapamil ou le diltiazem sont remplacés par des bêta-bloquants en cas d'insuffisance cardiaque.	412. Vrai
413.	La fibrillation auriculaire est caractérisée par une activité électrique auriculaire chaotique.	413. Vrai
414.	Le rythme de l'activité électrique auriculaire varie généralement entre 350 et 600 bpm lors de la FA.	414. Vrai
415.	La fibrillation auriculaire s'accompagne toujours d'une activité contractile auriculaire.	415. Faux
416.	La prévalence de la fibrillation auriculaire diminue avec le vieillissement.	416. Faux
417.	La fibrillation auriculaire est idiopathique chez un patient sur trois.	417. Vrai
418.	L'hypertension artérielle n'est pas une cause de fibrillation auriculaire.	418. Faux
419.	La chirurgie cardiothoracique peut induire la fibrillation auriculaire.	419. Vrai
420.	La fibrillation auriculaire peut être causée par une hyperthyroïdie.	420. Vrai
421.	La présence d'un thrombus dans l'oreillette gauche est rare chez les patients atteints de FA.	421. Faux

422.	Le score CHA ₂ DS ₂ -VASc permet d'évaluer le risque thromboembolique chez les patients atteints de FA.	422. Vrai
423.	Un score CHA ₂ DS ₂ -VASc de 0 nécessite un traitement par anticoagulant direct.	423. Faux
424.	La digoxine est contre-indiquée chez les patients atteints de fibrillation auriculaire.	424. Faux
425.	L'ablation du nœud auriculo-ventriculaire est un traitement de 1 ^{ère} intention pour la fibrillation auriculaire.	425. Faux
426.	Un pourcentage élevé de fibrillations auriculaires se résout spontanément dans les 48 heures.	426. Vrai
427.	La cardioversion électrique externe est préférable en cas d'instabilité hémodynamique lors de la FA.	427. Vrai
428.	Le vernakalant peut être administré par voie orale pour traiter la fibrillation auriculaire.	428. Faux
429.	Une association de différents antiarythmiques est recommandé pour traiter la fibrillation auriculaire.	429. Faux
430.	La prise en charge de la fibrillation auriculaire ne nécessite pas de suivi rapproché.	430. Faux
431.	L'amiodarone est un traitement efficace pour la FA mais présente beaucoup d'effets secondaires.	431. Vrai
432.	L'isolation des veines pulmonaires par radiofréquence est un traitement invasif utilisé en dernier recours pour la fibrillation auriculaire.	432. Vrai
433.	L'isolation des veines pulmonaires par radiofréquence comporte un risque de décès procédural <1/1000.	433. Vrai
434.	La fibrillation auriculaire peut être asymptomatique chez certains patients.	434. Vrai
435.	Les traitements antiarythmiques ne comportent jamais d'effets secondaires.	435. Faux

436.	La correction des facteurs de risque cardiovasculaires permet de prévenir les récives de FA.	436. Vrai
437.	Les antivitamines K sont toujours préférés aux anticoagulants directs chez les patients atteints de FA.	437. Faux
438.	Le Score HAS-BLED permet de prédire le risque hémorragique sous anticoagulation.	438. Vrai
439.	La cardioversion électrique est inefficace pour traiter une FA causée par une hyperthyroïdie.	439. Vrai
440.	Les palpitations sont un symptôme fréquent de la fibrillation auriculaire.	440. Vrai
441.	Un score CHA ₂ DS ₂ -VASc de 0 indique un risque élevé de thromboembolie chez les patients atteints de FA.	441. Faux
442.	La fibrillation auriculaire peut être traitée avec succès par une cardioversion pharmacologique.	442. Vrai
443.	La fibrillation auriculaire peut être diagnostiquée par un électrocardiogramme.	443. Vrai
444.	Les anticoagulants directs sont toujours moins efficaces que les antivitamines K en cas de FA.	444. Faux
445.	Les médicaments antiarythmiques de classe I sont sans danger pour les patients atteints de FA.	445. Faux
446.	La prise en charge de la fibrillation auriculaire nécessite toujours un traitement antithrombotique.	446. Faux
447.	La FA est due à de multiples petites vagues de réentrée auriculaire.	447. Vrai
448.	La prévalence de la FA est de 25% après 80 ans.	448. Faux
449.	La prévalence de la FA augmente avec le vieillissement.	449. Vrai
450.	1/3 des cas de fibrillation auriculaire sont idiopathiques.	450. Vrai

451.	Le rythme de l'activité électrique auriculaire varie généralement entre 150 et 250bpm lors de la FA.	451. Faux
452.	La péricardite, l'embolie pulmonaire, le diabète et l'apnée du sommeil favorisent la FA.	452. Vrai
453.	20% des patients atteints d'une cardiopathie dilatée sont en fibrillation auriculaire.	453. Vrai
454.	L'abus d'alcool favorise la FA uniquement en présence de cardiomyopathie.	454. Faux
455.	La cardiomyopathie ischémique peut être associée à la fibrillation auriculaire.	455. Vrai
456.	20 à 40% des patients présentent une FA entre le 2 ^{ème} et le 8 ^{ème} jour après une chirurgie cardiothoracique.	456. Vrai
457.	Il faut généralement cardioverser les FA secondaires à une chirurgie cardiothoracique.	457. Faux
458.	Les pathologies valvulaires et en particulier la sténose mitrale favorisent la FA.	458. Vrai
459.	La FA se resinusalise généralement spontanément 10-14 jours après une chirurgie cardiothoracique.	459. Vrai
460.	Il ne faut pas cardioverser les FA secondaires à une hyperthyroïdie.	460. Vrai
461.	Les pathologies pulmonaires ne causent jamais de fibrillation auriculaire.	461. Faux
462.	La dilatation auriculaire prédispose à la FA mais pas l'hypertrophie auriculaire.	462. Faux
463.	Une infiltration graisseuse ou amyloïde du myocarde peut induire de la FA.	463. Vrai
464.	La fibrose, la nécrose et l'inflammation myocardique prédisposent à la fibrillation auriculaire.	464. Vrai
465.	La FA est souvent accompagnée d'un rythme ventriculaire régulier.	465. Faux

466. La fibrillation auriculaire induit une perte de l'activité mécanique ventriculaire.	466. Faux
467. La FA réduit d'autant plus le débit cardiaque que la fonction ventriculaire est altérée et qu'elle devient tributaire de la contraction auriculaire.	467. Vrai
468. Le débit cardiaque peut diminuer de 50% suite à la fibrillation auriculaire.	468. Faux
469. La fibrillation auriculaire peut entraîner une dyspnée et une insuffisance cardiaque.	469. Vrai
470. Le remodelage électrique auriculaire augmente le risque de récurrences de FA après resinusalisation.	470. Vrai
471. La perte de la diastole auriculaire augmente le risque de thromboembolie.	471. Faux
472. La fibrillation auriculaire paroxystique est caractérisé par des épisodes récurrents de moins de 3 jours.	472. Faux
473. Il existe des cas de FA soutenue non-resinusalisable où il n'y a plus d'espoir de rétablir un rythme sinusal.	473. Vrai
474. La FA soutenue re-sinusalisable est caractérisée par des épisodes récurrents de 7 jours ou plus.	474. Vrai
475. Les épisodes de FA paroxystique durent maximum une semaine.	475. Vrai
476. Les symptômes de la FA sont très nombreux : palpitations, agitation, dyspnée, insuffisance cardiaque congestive, angor, embolies, syncopes (associée à la maladie du sinus),...	476. Faux
477. La fibrillation auriculaire est toujours symptomatique.	477. Faux
478. La FA soutenue re-sinusalisable s'arrête parfois spontanément en plus de 7 jours.	478. Faux

479.	La FA soutenue re-sinusalisable est une FA persistante qui ne peut être arrêtée que par une cardioversion.	479. Vrai
480.	Le débit cardiaque peut chuter de 30% en cas de fibrillation auriculaire.	480. Vrai
481.	La maladie du sinus représente 70% des indications de stimulateur cardiaque.	481. Faux
482.	La FA paroxystique s'arrête parfois spontanément endéans les 7 jours.	482. Vrai
483.	La prévalence de la fibrillation auriculaire est de 10% après 80 ans.	483. Vrai
484.	La fibrillation auriculaire ne cause jamais d'AVC embolique.	484. Faux
485.	La resinusalisation doit être réalisée avant l'anticoagulation dans le traitement de la FA.	485. Faux
486.	La biologie sanguine, la radio de thorax et l'épreuve d'effort permettent de rechercher la cause de la FA.	486. Vrai
487.	L'ECG montre des ondes P irrégulières et un intervalle RR variable en cas de FA.	487. Faux
488.	L'épisode d'ECG anormal doit durer au moins 30 secondes pour être considéré comme de la FA.	488. Vrai
489.	Des oscillations rapides de la ligne de base sans onde P pendant <30 secondes est considéré comme une tachyarythmie supra-ventriculaire mais pas comme une fibrillation auriculaire.	489. Vrai
490.	L'échographie transthoracique montre un thrombus dans l'auricule gauche dans 1/3 des cas si la FA >3j.	490. Faux
491.	L'échographie cardiaque permet de voir une dilatation auriculaire ou une pathologie mitrale en cas de FA.	491. Vrai
492.	La flécaïnide et le propafénone sont des anti-arythmiques de classe 3.	492. Faux

493. Les anti-arythmiques de classe 2 sont des bêta-bloquants.	493. Vrai
494. Les anti-arythmiques de classe 1 sont des antagonistes calciques bradycardisants.	494. Faux
495. L'amiodarone et le sotalol allongent le temps de repolarisation.	495. Vrai
496. Les anti-arythmiques de classe 1 bloquent les canaux sodiques.	496. Vrai
497. Une FA consécutive à une sténose mitrale modérée à sévère doit être anticoagulée par AVK.	497. Vrai
498. Les anticoagulants directs sont indiqués pour les patients porteurs d'une valve mécanique.	498. Faux
499. Le score CHA ₂ DS ₂ -VASc calcule le besoin d'anticoagulation d'une FA consécutive à une pathologie mitrale.	499. Faux
500. Un score CHA ₂ DS ₂ -VASc = 1 pour une femme indique qu'un anticoagulant direct est préférable à un AVK.	500. Faux
501. Le Score HAS-BLED permet de prédire le risque thrombotique chez les patients atteints de FA.	501. Faux
502. Le traitement visant à ralentir la réponse ventriculaire à la FA est principalement symptomatique et ne modifie pas le pronostic du patient.	502. Vrai
503. La digoxine est un bon choix pour ralentir le rythme ventriculaire chez les patients insuffisants cardiaques.	503. Vrai
504. Les bêta-bloquants sont contre-indiqués chez les patients présentant une pré-excitation.	504. Faux
505. L'ablation du NAV est envisagée en dernier recours pour le traitement de la fibrillation auriculaire.	505. Vrai
506. 80% des FA récentes se résolvent spontanément dans les 48 heures.	506. Vrai

507. Une anticoagulation et une CEE sont recommandés en cas de FA avec instabilité hémodynamique.	507. Vrai
508. La cardioversion électrique externe est recommandée pour les FA <48h avec stabilité hémodynamique.	508. Vrai
509. Si la FA persiste depuis plus de 48 heures, l'administration d'un traitement resinusalisant est autorisée.	509. Faux
510. L'efficacité de la CEE dépend uniquement de la durée de la FA et de la gravité de la pathologie cardiaque.	510. Faux
511. La cardioversion pharmacologique est envisageable en cas de FA récente avec stabilité hémodynamique.	511. Vrai
512. Le vernakalant est contre-indiqué en cas de sténose aortique serrée.	512. Vrai
513. La flecainide peut être utilisé même en présence de flutter auriculaire.	513. Faux
514. La dysthyroïdie est une contre-indication absolue au traitement de la FA par amiodarone.	514. Faux
515. L'ibutilide est contre-indiqué en cas de QT prolongé.	515. Vrai
516. L'automédication en cas d'accès de FA est possible après une hospitalisation.	516. Vrai
517. Les mesures hygiéno-diététiques ne sont pas efficaces pour prévenir les récives de FA.	517. Faux
518. Il est recommandé d'associer différents antiarythmiques pour un meilleur contrôle de la FA.	518. Faux
519. La flecainide est contre-indiquée en cas de cardiopathie ischémique ou de FEVG réduite.	519. Faux
520. L'amiodarone est le traitement le plus efficace pour la FA, mais aussi le plus toxique à long terme.	520. Vrai
521. Il existe un risque de décès procédural associé à l'isolation des veines pulmonaires.	521. Vrai

522. L'isolation des veines pulmonaires par radiofréquence est recommandée après au moins 3 tentatives de traitement pharmacologique inefficaces.	522. Faux
523. Les anticoagulants directs sont préférables aux antivitamines K chez les hommes avec $CHA_2DS_2-VASc = 2$.	523. Faux
524. La digoxine est contre-indiquée chez les patients insuffisants cardiaques.	524. Faux
525. Le pourcentage de résolution spontanée est plus élevé chez les patients ayant une FA chronique.	525. Faux
526. Les antagonistes calciques sont contre-indiqués chez les patients insuffisants cardiaques.	526. Vrai
527. L'automédication en cas d'accès de FA est sûre et efficace sans surveillance médicale.	527. Faux
528. L'isolation des veines pulmonaires est recommandé en 1ère intention chez tous les cas de FA.	528. Faux
529. La cardioversion pharmacologique est contre-indiquée en présence d'une altération de la conduction AV.	529. Vrai
530. L'isolation des veines pulmonaires est associée à un risque accru de thrombose veineuse profonde.	530. Faux
531. La CEE est toujours efficace pour restaurer le rythme sinusal chez les patients atteints de FA.	531. Faux
532. Le traitement de la fibrillation auriculaire vise uniquement à supprimer les symptômes.	532. Faux
533. Les anticoagulants oraux directs sont plus efficaces que les antivitamines K pour prévenir les accidents thromboemboliques chez les hommes avec un $CHA_2DS_2-VASc = 1$.	533. Vrai
534. Le traitement resinusalisant est interdit chez les patients présentant une FA depuis plus de 48 heures.	534. Vrai

535.	La prise de flecainide est recommandée chez les patients ayant une cardiopathie ischémique.	535. Faux
536.	L'automédication en cas d'accès de FA est recommandée sans consultation médicale préalable.	536. Faux
537.	L'administration d'amiodarone est déconseillée chez les patients présentant une FEVG réduite.	537. Faux
538.	La digoxine augmente l'activité sympathique.	538. Faux
539.	Les bêta-bloquants peuvent être utilisés en association avec les antagonistes calciques pour ralentir le rythme ventriculaire chez les patients atteints de fibrillation auriculaire.	539. Faux
540.	L'amiodarone est le traitement le moins toxique parmi les antiarythmiques.	540. Faux
541.	La cardioversion pharmacologique est contre-indiquée en cas d'allongement du QTc > 500ms.	541. Vrai
542.	L'ablation du NAV est associée à un risque accru de bloc auriculo-ventriculaire complet.	542. Vrai
543.	Le traitement resinusalisant est autorisé chez les patients présentant une FA depuis moins de 24 heures.	543. Vrai
544.	Les anticoagulants oraux directs ont un profil de sécurité similaire aux antivitamines K.	544. Faux
545.	L'isolation des veines pulmonaires est contre-indiquée en cas de tachycardiomyopathie réfractaire.	545. Faux
546.	L'amiodarone et le sotalol sont des anti-arythmiques de classe 3.	546. Vrai
547.	L'administration d'amiodarone est contre-indiquée en cas de torsades de pointes.	547. Vrai
548.	L'automédication en cas d'accès de FA est aussi efficace qu'une resinusalisation en milieu hospitalier.	548. Faux

549.	Les anticoagulants oraux directs nécessitent un suivi plus fréquent que les antivitamines K.	549. Faux
550.	Le traitement resinusalisant est autorisé chez les patients présentant une FA depuis plus de 48 heures s'ils ont bénéficié d'une échographie transœsophagienne montrant l'absence de thrombus auriculaire.	550. Vrai
551.	Les antiarythmiques de classe IV sont contre-indiqués en cas d'insuffisance cardiaque.	551. Vrai
552.	Les anticoagulants directs sont recommandés en cas de sténose mitrale modérée à sévère.	552. Faux
553.	Les porteurs d'une valve mécanique doivent toujours être anticoagulés par antivitamines K.	553. Vrai
554.	L'insuffisance cardiaque vaut pour 2 points dans le score CHA ₂ DS ₂ -VASc.	554. Faux
555.	Le sexe masculin vaut pour 1 point dans le score CHA ₂ DS ₂ -VASc.	555. Faux
556.	L'hypertension artérielle vaut pour 1 point dans le score CHA ₂ DS ₂ -VASc.	556. Vrai
557.	Le diabète de type 1 ou de type 2 vaut pour 1 point dans le score HAS-BLED.	557. Faux
558.	Un antécédent d'AIT vaut pour 2 points dans le score CHA ₂ DS ₂ -VASc.	558. Vrai
559.	Un antécédent d'AVC vaut pour 3 points dans le score CHA ₂ DS ₂ -VASc.	559. Faux
560.	Un antécédent d'infarctus du myocarde vaut pour 2 points dans le score CHA ₂ DS ₂ -VASc.	560. Faux
561.	Un antécédent de maladie vasculaire comme l'AOMI vaut pour 1 point dans le score CHA ₂ DS ₂ -VASc.	561. Vrai
562.	Un âge supérieur à 75 ans vaut pour 1 point dans le score CHA ₂ DS ₂ -VASc.	562. Faux

563. Un âge compris entre 65 et 74 ans vaut pour 1 point dans le score CHA ₂ DS ₂ -VASc.	563. Vrai
564. Le sexe féminin vaut pour 1 point dans le score CHA ₂ DS ₂ -VASc.	564. Vrai
565. Les AVK sont moins efficaces et causent plus d'hémorragies chez une femme avec CHA ₂ DS ₂ -VASc = 2.	565. Vrai
566. Il n'existe aucun cas de FA qui ne doit pas recevoir de traitement anticoagulant.	566. Faux
567. Le traitement de la FA vise à ralentir la réponse ventriculaire à la FA ou à rétablir un rythme sinusal.	567. Vrai
568. L'objectif du traitement de la FA est de ralentir le rythme ventriculaire <100bpm au repos.	568. Faux
569. La digoxine à haute dose sert à augmenter l'activité vagale pour traiter la FA.	569. Faux
570. Le stimulateur cardiaque ventriculaire est un traitement de dernier recours en cas de FA.	570. Vrai
571. Une minorité des cas de FA se résout spontanément endéans 48h.	571. Faux
572. 80% des FA récentes se resinusalisent spontanément endéans les 24h.	572. Faux
573. Si la FA dure depuis >48h, une anticoagulation de 2-3 semaines sera nécessaire avant la CEE.	573. Vrai
574. Une anticoagulation de 2-3 semaines sera nécessaire après la CEE si la FA dure depuis >48h.	574. Faux
575. L'auricule récupère immédiatement une contractilité normale après la CEE d'une FA de >48h.	575. Faux
576. Un score CHA ₂ DS ₂ -VASc = 1 pour un homme indique qu'un anticoagulant direct est préférable à un AVK.	576. Vrai
577. Un score CHA ₂ DS ₂ -VASc = 3 pour une femme indique qu'un anticoagulant direct est préférable à un AVK.	577. Faux

578. Un score CHA ₂ DS ₂ -VASc = 2 pour une homme indique qu'un AVK est préférable à un anticoagulant direct.	578. Vrai
579. La CEE est autorisée en cas de FA >48h si l'échographie transthoracique a montré l'absence de thrombus.	579. Faux
580. Une anticoagulation d'au moins 4 semaines est nécessaire après la CEE dans tous les cas de FA >48h.	580. Vrai
581. La CEE est plus efficace si l'oreillette gauche est très dilatée.	581. Faux
582. La CEE est moins efficace si la FA dure depuis longtemps ou si la pathologie cardiaque est avancée.	582. Vrai
583. L'efficacité de la CEE est diminuée si le patient a reçu un traitement préalable par amiodarone.	583. Faux
584. La kaliémie optimale est de <4,5mEq/L pour réaliser une cardioversion électrique externe.	584. Faux
585. La cardioversion pharmacologique est contre-indiquée en cas de maladie du sinus associée à la FA.	585. Vrai
586. La cardioversion pharmacologique est envisageable pour traiter une FA ancienne.	586. Faux
587. La cardioversion pharmacologique nécessite une surveillance continue de l'ECG et des paramètres cardio-respiratoires.	587. Vrai
588. Le vernakalant est un traitement hypertenseur utilisé dans la cardioversion pharmacologique de la FA.	588. Faux
589. L'hypotension, la dyspnée NYHA III-IV ou le QT allongé sont des contre-indications au vernakalant.	589. Vrai
590. Le vernakalant entraine une resinusualisation d'environ 90% des FA endéans les 10 minutes.	590. Faux
591. Les antiarythmiques de classe I (flecainide ou propaferone) peuvent être administrés PO en cas de FA.	591. Vrai

592. La flecainide ou le propaferone modifient la FA en flutter 1/1 dans 5% des cas.	592. Vrai
593. Les antiarythmiques de classe 1 doivent être associés à un bêta-bloquant ou au diltiazem.	593. Vrai
594. La flecainide ou le propaférone sont contre-indiqués en cas de flutter.	594. Vrai
595. L'efficacité de la CEE est augmentée par un pré-traitement par amiodarone.	595. Vrai
596. La flecainide et le propaferone entraîne une resinusalisation plus rapide que le vernakalant en cas de FA.	596. Faux
597. L'amiodarone est utilisée en 1 ^{ère} intention pour traiter la FA secondaire à une dysthyroïdie.	597. Faux
598. L'amiodarone est préférable pour la cardioversion pharmacologique en cas d'insuffisance cardiaque.	598. Vrai
599. L'amiodarone permet de resinusaliser environ 40% des FA endéans quelques jours.	599. Vrai
600. Phlébite, hypotension, tachycardie, BAV et QT allongé sont des contre-indications à l'amiodarone.	600. Faux
601. L'ibutilide entraîne une resinusalisation plus rapide que l'amiodarone en cas de FA.	601. Vrai
602. L'ibutilide induit des torsades de pointe et est contre-indiqué en cas de QT prolongé.	602. Vrai
603. L'ibutilide est indiqué dans le traitement de la FA en cas de FEVG abaissée.	603. Faux
604. L'hypertrophie ventriculaire gauche sévère est une contre-indication à l'ibutilide.	604. Vrai
605. L'automédication pour les accès de FA est réservé aux patients dont la conduction auriculo-ventriculaire est préalablement ralentie par un bêta-bloquant ou du diltiazem.	605. Vrai

606.	L'automédication consiste à s'administrer une dose de charge de vernakalant au début d'un accès de FA.	606. Faux
607.	L'automédication en cas de FA est administrée par voie intramusculaire.	607. Faux
608.	La correction des facteurs de risque cardiovasculaires ne modifie pas l'incidence des récurrences de FA.	608. Faux
609.	L'exercice physique d'intensité modérée est recommandé pour éviter les récurrences de FA.	609. Vrai
610.	Les symptômes de la FA doivent être très sévères pour justifier un traitement antiarythmique chronique.	610. Vrai
611.	La flecainide prévient les récurrences de FA.	611. Vrai
612.	La flecainide est contre-indiquée uniquement en cas d'altération de la fonction rénale ou hépatique.	612. Faux
613.	La flecainide est indiquée dans le traitement de la FA en cas de cardiopathie ischémique à FEVG réduite.	613. Faux
614.	Le traitement de la FA par flecainide doit être arrêté si le complexe QRS s'élargit ou si des altérations de la conduction auriculo-ventriculaire apparaissent.	614. Vrai
615.	La flecainide a l'avantage d'entraîner peu d'interactions médicamenteuses.	615. Faux
616.	L'amiodarone provoque une toxicité rénale, pulmonaire et thyroïdienne.	616. Faux
617.	L'amiodarone allonge le QT mais provoque rarement des torsades de pointe.	617. Vrai
618.	L'amiodarone peut être administrée en cas de FEVG réduite.	618. Vrai
619.	Le traitement par amiodarone doit être arrêté si l'intervalle QT dépasse 300ms.	619. Faux

620. L'amiodarone entraîne de nombreuses interactions médicamenteuses.	620. Vrai
621. L'isolation des veines pulmonaires par radiofréquence est recommandée après au moins 1 tentative de traitement pharmacologique inefficace.	621. Vrai
622. L'isolation des veines pulmonaires par radiofréquence est plus efficace que le traitement pharmacologique de classe I ou III pour maintenir le rythme sinusal et pour améliorer les symptômes.	622. Vrai
623. Le décès survient surtout par tamponnade en cas d'isolation des veines pulmonaires par radiofréquence.	623. Vrai
624. L'anticoagulation peut être arrêtée si le patient reste en rythme sinusal après le traitement invasif de la FA.	624. Faux
625. En cas de FEVG réduite, le traitement invasif de la FA améliore la qualité de vie et la fonction VG.	625. Vrai
626. En cas de FEVG réduite, le traitement invasif de la FA tend à réduire les hospitalisations pour insuffisance cardiaque mais pas la mortalité.	626. Faux
627. Le flutter auriculaire typique est dû à une arythmie par réentrée qui emprunte une voie de conduction lente située dans la région antérieure de l'oreillette droite.	627. Faux
628. Le circuit de réentrée est confiné à l'oreillette droite et n'entreprend pas l'oreillette gauche en cas de flutter.	628. Vrai
629. Le circuit de réentrée tourne dans un sens horaire en cas de flutter si on regarde l'OD par l'apex.	629. Faux
630. Le flutter est associé à une dilatation des oreillettes causée par des pathologies valvulaires ou pulmonaires.	630. Vrai

631.	L'arythmie du flutter auriculaire persiste généralement pendant plusieurs heures ou jours.	631. Vrai
632.	Le flutter est caractérisé par des « dents de scie » mieux visualisés dans les dérivations antérieures de l'ECG.	632. Faux
633.	Les médicaments antiarythmiques de classe I peuvent induire une conduction auriculo-ventriculaire 1/1.	633. Vrai
634.	Le massage du sinus carotidien facilite le diagnostic électrocardiographique du flutter 1/1 ou 2/1.	634. Vrai
635.	Le flutter atypique est généralement caractérisé des fluctuations sinusoïdales de la ligne de base de l'ECG.	635. Vrai
636.	Les antiarythmiques disponibles en Belgique re-sinualisent facilement le flutter auriculaire.	636. Faux
637.	L'adénosine est recommandée pour traiter les accès de flutter auriculaire.	637. Faux
638.	L'ablation par radio-fréquence du circuit de réentrée est recommandée en cas de flutter typique récurrent.	638. Vrai
639.	L'HTA, l'IC et le diabète sucré sont des facteurs de risque de thromboembolie en cas de flutter.	639. Vrai
640.	La majorité des patients en flutter auriculaire ont un thrombus dans l'auricule gauche.	640. Faux
641.	Les recommandations pour l'anticoagulation sont différentes entre la FA et le flutter auriculaire.	641. Faux
642.	La dépolarisation auriculaire du flutter tourne en sens antihoraire si on regarde l'OD par la pointe du cœur.	642. Vrai
643.	Les bêta-bloquants ne sont pas efficaces pour ralentir la réponse ventriculaire en cas de flutter auriculaire.	643. Faux
644.	Les antiarythmiques de classe I peuvent être administrés seuls en cas de flutter auriculaire.	644. Faux
645.	La cardioversion électrique est moins efficace que les médicaments pour re-sinusaliser le flutter auriculaire.	645. Faux

646. Le flutter auriculaire typique ne peut pas être traité par ablation par radio-fréquence.	646. Faux
647. L'ablation par radio-fréquence est plus favorable en cas de flutter auriculaire atypique que typique.	647. Faux
648. Les antiarythmiques de classe I sont les médicaments de choix pour le traitement du flutter auriculaire.	648. Faux
649. Le flutter auriculaire typique alterne toujours avec des périodes de fibrillation auriculaire.	649. Faux
650. Les « dents de scie » du flutter sont mieux visualisées dans les dérivations inférieures (D2, D3, aVF) à l'ECG.	650. Vrai
651. Le flutter est caractérisé par une activité électrique irrégulière auriculaire à une fréquence de 300bpm.	651. Faux
652. Le rythme ventriculaire est toujours d'environ 150bpm en cas de flutter.	652. Faux
653. On peut observer un flutter auriculaire avec une fréquence cardiaque normale.	653. Vrai
654. Les antiarythmiques de classe 1 risquent d'induire un collapsus hémodynamique en cas de flutter.	654. Vrai
655. Le flutter atypique emprunte le même circuit de réentrée que le flutter typique dans un sens opposé.	655. Faux
656. La conduction auriculaire 4/1 donne un rythme ventriculaire à 100bpm en cas de flutter.	656. Faux
657. Le massage du sinus carotidien permet de visualiser les ondes de flutter en altérant transitoirement la conduction auriculo-ventriculaire (surtout utile pour le flutter 1/1 ou 2/1).	657. Vrai
658. Le flutter atypique peut prendre l'aspect d'une FA organisée dont la fréquence est à >300bpm.	658. Vrai
659. L'électrophysiologie précise le mécanisme responsable de l'arythmie en cas de flutter atypique.	659. Vrai

660. Les médicaments antiarythmiques de classe II peuvent induire une conduction AV 1/1 en cas de flutter.	660. Faux
661. Plusieurs traitements peuvent être utilisés pour réduire la fréquence ventriculaire pendant un accès de tachycardie en cas de flutter : digoxine, bêta-bloquants, amlodipine, amiodarone (si IC),...	661. Faux
662. La cardioversion électrique resinusalise facilement le flutter avec une énergie faible de 25 à 100 joules.	662. Vrai
663. L'adénosine peut induire une conduction 1/1 ou une FA rapide et ne doit pas être donnée en cas de flutter.	663. Vrai
664. Les antiarythmiques de classe I doivent toujours être associés à un médicament qui bloque la conduction auriculo-ventriculaire en cas de flutter.	664. Vrai
665. Les bêta-bloquants, l'amiodarone (si IC) et le diltiazem sont utilisés pour traiter une récurrence de flutter.	665. Vrai
666. La prévention pharmacologique des récurrences de flutter risque de ralentir le rythme ventriculaire.	666. Faux
667. Les antiarythmiques de classe I ne sont jamais donnés sans blocage de la conduction AV en cas de flutter.	667. Vrai
668. L'amiodarone est très efficace pour resinusaliser les accès de flutter auriculaire.	668. Faux
669. L'ablation par radiofréquence du circuit de réentrée est moins favorable en cas de flutter atypique.	669. Vrai
670. 10% des patients en flutter ont un thrombus dans l'auricule gauche à l'échographie transoesophagienne.	670. Vrai
671. L'anticoagulation n'est jamais nécessaire en cas de flutter typique.	671. Faux
672. Les extrasystoles ventriculaires sont des dépolarisations ventriculaires spontanées et récurrentes.	672. Faux

673.	Le pronostic des extrasystoles ventriculaires dépend de l'affection cardiaque sous-jacente.	673. Vrai
674.	Les extrasystoles ventriculaires ne sont jamais bénignes.	674. Faux
675.	Les ESV sont de mauvais pronostic après un infarctus (>10 ESV/h) ou en cas d'IC (>720 ESV/24h).	675. Vrai
676.	Le débit cardiaque peut être augmenté par des ESV fréquentes.	676. Faux
677.	L'ESV se manifeste à l'ECG par un complexe QRS fin non précédé d'une onde P.	677. Faux
678.	Le QRS est parfois multiple et polymorphe à l'ECG en cas d'extrasystole ventriculaire.	678. Vrai
679.	La suppression des extrasystoles ventriculaires par les antiarythmiques de classe I aggrave la mortalité dans la cardiopathie ischémique.	679. Vrai
680.	Le traitement des ESV est composé de lidocaïne IV pendant la phase aigüe de l'infarctus.	680. Vrai
681.	Les bêta-bloquants sont contre-indiqués en cas d'extrasystole ventriculaire.	681. Faux
682.	La tachycardie ventriculaire est souvent le premier événement qui dégénère en fibrillation ventriculaire.	682. Vrai
683.	La tachycardie ventriculaire et la fibrillation ventriculaire sont des sources majeures de mort subite.	683. Vrai
684.	La TV est généralement induite par un mécanisme de réentrée chez des patients avec un myocarde altéré.	684. Vrai
685.	La tachycardie ventriculaire est caractérisée par un rythme cardiaque rapide d'origine sinusale.	685. Faux
686.	La fibrillation ventriculaire se caractérise par une activité électrique ventriculaire rapide et organisée.	686. Faux

687.	La symptomatologie de la tachycardie ventriculaire dépend uniquement de la fréquence cardiaque.	687. Faux
688.	La tolérance hémodynamique à la TV est toujours excellente si la fonction cardiaque est normale.	688. Faux
689.	La TV lente peut entraîner de la dyspnée, des palpitations et des œdèmes pulmonaires et périphériques.	689. Vrai
690.	La tachycardie ventriculaire rapide peut induire un collapsus hémodynamique.	690. Vrai
691.	Les « ondes de canon » jugulaires irrégulières sont un signe typique de la tachycardie ventriculaire.	691. Vrai
692.	La fibrillation ventriculaire entraîne un collapsus circulatoire endéans 3 à 10 secondes.	692. Vrai
693.	La fibrillation ventriculaire peut être traitée par une cardioversion électrique.	693. Vrai
694.	L'ECG dans la tachycardie ventriculaire montre des complexes QRS uniformes.	694. Vrai
695.	La TV de morphologie de type bloc de branche gauche montre des complexes QRS positifs en V1.	695. Faux
696.	Une tachycardie supra-ventriculaire avec un bloc de branche ressemble toujours à une TV à l'ECG.	696. Vrai
697.	L'axe du complexe QRS dans la tachycardie ventriculaire est généralement compris entre -60° et -180°.	697. Vrai
698.	La dissociation auriculo-ventriculaire est un signe en faveur de la tachycardie supra-ventriculaire.	698. Faux
699.	La lidocaïne est le traitement de choix pour la tachycardie ventriculaire aiguë.	699. Faux
700.	La cardioversion électrique est préférable au traitement pharmacologique pour la TV instable.	700. Vrai
701.	Les bêta-bloquants sont le traitement de choix pour la TV précoce dans l'infarctus myocardique aigu.	701. Vrai

702.	Un défibrillateur implantable est indiqué pour la TV non soutenue en cas de cardiopathie ischémique.	702. Vrai
703.	L'ablation par radiofréquence est peu utile dans le traitement de la tachycardie ventriculaire.	703. Faux
704.	La cardioversion électrique est le traitement de choix pour la fibrillation ventriculaire aiguë.	704. Vrai
705.	La mort arythmique est supprimée par le défibrillateur implantable.	705. Vrai
706.	La classe NYHA est un facteur prédictif de la survie après l'implantation d'un défibrillateur interne.	706. Vrai
707.	La tachycardie ventriculaire est rarement associée à une cardiopathie ischémique.	707. Faux
708.	La tachycardie ventriculaire peut être induite par l'exercice physique et l'isoprotérénol chez les <50 ans.	708. Vrai
709.	La TV induite par l'exercice physique a un aspect de bloc de branche gauche.	709. Vrai
710.	Les cardiomyopathies dilatée et hypertrophique sont associées à la tachycardie ventriculaire.	710. Vrai
711.	La cardiomyopathie arythmogène ventriculaire droite est caractérisée par un VD atrophié et hypokinétique.	711. Faux
712.	La cardiomyopathie arythmogène ventriculaire droite répond bien au traitement par la digoxine.	712. Faux
713.	L'ECG dans la TV montre des oscillations à larges mailles sans complexe QRS discernable.	713. Faux
714.	L'étude électrophysiologique permet toujours de reproduire l'arythmie chez les patients atteints de TV.	714. Faux
715.	Le défibrillateur implantable est indiqué pour la TV non soutenue avec dysfonction ventriculaire gauche.	715. Vrai
716.	L'utilisation de plusieurs antiarythmiques différents est recommandée pour le traitement de la TV.	716. Faux

717. La fibrillation ventriculaire se manifeste par des oscillations à larges mailles sans complexes QRS à l'ECG.	717. Vrai
718. Le myocarde altéré présente des ilots de muscle normal alternés avec des zones de nécrose/fibrose qui conduisent lentement la dépolarisation électrique et génèrent des circuits de réentrée.	718. Vrai
719. La FV se caractérise par une activité électrique ventriculaire totalement désorganisée.	719. Vrai
720. La fibrillation ventriculaire s'accompagne d'une activité contractile chaotique des ventricules.	720. Faux
721. En cas de cardiomyopathie dilatée, le circuit de réentrée à l'origine de la TV passe par les branches de conduction et le septum interventriculaire dans 50% des cas.	721. Vrai
722. Les symptômes dépendent de l'adéquation de la réponse du système nerveux autonome à la TV.	722. Vrai
723. La TV lente est caractérisée par un rythme ventriculaire <200 bpm.	723. Faux
724. La tachycardie ventriculaire n'entraîne jamais d'œdème pulmonaire.	724. Faux
725. La TV rapide et soutenue avec dysfonction ventriculaire entraîne une syncope ou une mort subite.	725. Vrai
726. L'examen physique révèle une tachycardie irrégulière et un B1 de tonalité variable en cas de TV.	726. Faux
727. Le rythme de la fibrillation ventriculaire varie entre 150 et 300 bpm.	727. Vrai
728. Le circuit de réentrée à l'origine de la TV monomorphe est situé à la frontière entre le myocarde malade et le myocarde sain en cas de cardiopathie ischémique.	728. Vrai

729. Le VG est généralement indemne en cas de cardiomyopathie arythmogène ventriculaire droite.	729. Vrai
730. Le ventricule droit est dilaté et hypokinétique en raison d'une infiltration amyloïde en cas de cardiomyopathie arythmogène ventriculaire droite	730. Faux
731. L'ECG montre des ondes T positives dans les dérivations précordiales droites en cas de cardiomyopathie arythmogène ventriculaire droite.	731. Faux
732. L'arythmie répond bien au sotalol en cas de cardiomyopathie arythmogène ventriculaire droite.	732. Vrai
733. Chez le patient sain de <50 ans, la TV a le plus souvent un aspect de bloc de branche gauche.	733. Vrai
734. Le foyer arythmogène à l'origine de la TV est situé dans la chambre de chasse du VG dans un cœur sain.	734. Faux
735. La TV peut être guérie par une ablation par radiofréquence chez le sujet sain de <50 ans.	735. Vrai
736. La TV fasciculaire survient chez le patient âgé atteint d'une cardiomyopathie sous-jacente.	736. Faux
737. Le syndrome de Brugada, le syndrome du QT long et le prolapsus valvulaire mitral sont des causes fréquentes de tachycardie ventriculaire.	737. Faux
738. Les cardiopathies ischémique, dilatée et hypertrophique sont les 3 causes les plus fréquentes de TV.	738. Vrai
739. La fibrillation ventriculaire entraîne un collapsus circulatoire en moins de 2-3 minutes.	739. Faux
740. La fibrillation ventriculaire entraîne le décès en l'absence de cardioversion électrique.	740. Vrai

741. La TV est définie par plus de 5 battements consécutifs d'origine ventriculaire.	741. Faux
742. La tachycardie ventriculaire non soutenue dure entre 3 battements et 30 secondes.	742. Vrai
743. La TV de morphologie de type bloc de branche droit est caractérisée par des complexes QRS positifs en V1.	743. Vrai
744. La TV d'axe inférieur est caractérisée par des complexes QRS positifs en D2, D3 et aVR.	744. Faux
745. La TV de morphologie de type bloc de branche gauche est caractérisé par des QRS négatifs en V1.	745. Vrai
746. La TV d'axe supérieur est caractérisée par des complexes QRS négatifs en D2, D3 et aVF.	746. Vrai
747. On parle de tachycardie ventriculaire monomorphe si les complexes QRS sont uniformes.	747. Vrai
748. Une tachycardie supra-ventriculaire ressemble à une TV en l'absence d'un bloc de branche.	748. Faux
749. Un QRS très large ($>0,14s$ si BBD et $>0,16s$ si BBG) est un signe en faveur d'une tachycardie ventriculaire.	749. Vrai
750. Une cardiopathie ischémique avec séquelle d'infarctus est un signe en faveur d'une tachycardie supra-ventriculaire.	750. Faux
751. Un aspect de bloc de branche droit ou gauche typique est un signe en faveur d'une TV.	751. Faux
752. Un aspect Rr' en V1 ou $R < S$ en V6 est un signe en faveur d'une TV.	752. Vrai
753. Un intervalle RR irrégulier est un signe en faveur d'une tachycardie supra-ventriculaire.	753. Vrai
754. Un QRS $<0,14s$ si BBD et $<0,16s$ si BBG est un signe en faveur d'une tachycardie supra-ventriculaire.	754. Vrai

755. Un aspect de bloc de branche droit ou gauche atypique est un signe en faveur d'une TV.	755. Vrai
756. La concordance précordiale (+ ou -) est un signe en faveur d'une tachycardie supra-ventriculaire.	756. Faux
757. On parle de « complexe de capture » si le complexe QRS est généré par l'activité supra-ventriculaire.	757. Vrai
758. Un aspect de bloc de branche gauche ou droit atypique inchangé par rapport à celui d'un ECG précédent est un signe en faveur d'une tachycardie ventriculaire.	758. Faux
759. Dans le doute, on considère toujours que le patient a une tachycardie ventriculaire.	759. Vrai
760. L'étude électrophysiologique permet de reproduire l'arythmie chez 90% des rescapés de mort subite.	760. Faux
761. L'étude électrophysiologique permet de reproduire l'arythmie chez 25% des cas de syncopes inexpliquées dans un contexte de cardiopathie ischémique.	761. Vrai
762. L'étude électrophysiologique est peu sensible dans certaines conditions.	762. Vrai
763. L'étude électrophysiologique permet de reproduire l'arythmie chez 50% des patients dont la TV/FV n'a pas pu être documentée.	763. Faux
764. La cardioversion électrique nécessite une anesthésie locale si le patient est conscient.	764. Faux
765. La procainamide IV permet de réduire la fréquence de la TV puis de resinusaliser le rythme.	765. Vrai
766. La procainamide IV risque d'induire une hypotension et un allongement de l'intervalle QT.	766. Faux

767. La lidocaïne, le sotalol ou l'amiodarone IV sont utilisés pour traiter la TV avec stabilité hémodynamique.	767. Vrai
768. Le traitement de la TV ne doit pas abaisser la PA diastolique sous 70 mmHg.	768. Faux
769. Le passage en fibrillation ventriculaire est une indication de cardioversion électrique.	769. Vrai
770. Il faut éviter d'administrer simultanément plusieurs antiarythmiques différents.	770. Vrai
771. L'arrêt cardiaque suite à la TV/FV n'est pas une indication de mise en place d'un défibrillateur implantable.	771. Faux
772. La TV asymptomatique inductible à l'épreuve électrophysiologique est une indication de mise en place d'un défibrillateur implantable.	772. Vrai
773. La syncope d'origine indéterminée n'est pas une indication de mise en place d'un défibrillateur implantable.	773. Faux
774. La pathologie cardiaque familiale avec risque élevé de TV/FV est une indication de mise en place d'un défibrillateur implantable.	774. Vrai
775. La revascularisation myocardique a un effet favorable sur la TV secondaire à une cardiopathie ischémique.	775. Vrai
776. Le traitement aigu de la fibrillation auriculaire comprend une cardioversion électrique à 300 joules, un massage cardiaque externe, une ventilation assistée et une réanimation.	776. Faux
777. Une chirurgie du foyer arythmogène peut être utile dans certains cas sélectionnés de TV.	777. Vrai
778. Le pronostic de la TV est celui de la maladie sous-jacente.	778. Vrai

779.	Le défibrillateur implantable permet de réduire la mortalité non-arythmique en cas de TV.	779. Faux
780.	La classe NYHA et la FEVG sont des facteurs importants de survie après l'implantation d'un défibrillateur.	780. Vrai
781.	Les pathologies de la repolarisation cardiaque peuvent augmenter le risque de mort subite due à une tachycardie ventriculaire rapide polymorphe.	781. Vrai
782.	Le syndrome du QT long congénital est beaucoup plus fréquent que le syndrome du QT long acquis.	782. Faux
783.	Le syndrome du QT long congénital est caractérisé par des anomalies de l'onde T et U.	783. Vrai
784.	Les symptômes du syndrome du QT long congénital surviennent lors d'une activation orthosympathique.	784. Vrai
785.	La syncope et la mort subite sont des symptômes caractéristiques du syndrome du QT long acquis.	785. Vrai
786.	Les bradycardie et les BAV sont des facteurs favorisant de la syncope dans le syndrome du QT long acquis.	786. Vrai
787.	L'hyperkaliémie est un facteur favorisant de la mort subite dans le syndrome du QT long congénital.	787. Faux
788.	L'intervalle QT corrigé pour la fréquence cardiaque est $<0,48$ sec dans le syndrome du QT long congénital.	788. Faux
789.	Les bêta-bloquants sont un traitement de choix pour le syndrome du QT long congénital.	789. Vrai
790.	Le sulfate de magnésium est le traitement de choix pour les tachycardies ventriculaires non soutenues dans le syndrome du QT long acquis.	790. Vrai
791.	Une kaliémie en dessous de 4.5 meq/l est recommandé dans le traitement du syndrome du QT long acquis.	791. Faux

792.	Le défibrillateur implantable est souvent nécessaire dans le traitement du syndrome du QT long acquis.	792. Faux
793.	Les anomalies électrolytiques sont des facteurs favorisants dans le syndrome du QT long acquis.	793. Vrai
794.	L'ECG dans le syndrome du QT long congénital montre généralement des ondes T normales.	794. Faux
795.	Les médicaments antiarythmiques sont recommandés dans le syndrome du QT long acquis.	795. Faux
796.	Le syndrome du QT long congénital survient généralement chez des patients âgés de plus de 50 ans.	796. Faux
797.	La syncope dans le syndrome du QT long acquis est souvent induite par la peur ou l'exercice.	797. Faux
798.	La stimulateur cardiaque est recommandé en cas de syndrome du QT long acquis avec bradycardie.	798. Vrai
799.	Les antihistaminiques sont des médicaments connus pour prolonger l'intervalle QT.	799. Vrai
800.	Les patients atteints de syndrome du QT long acquis ont souvent des antécédents familiaux de syncope.	800. Faux
801.	Les pseudo-crisés d'épilepsie sont des manifestations caractéristiques du syndrome du QT long congénital.	801. Vrai
802.	La « torsade de pointe » est une tachycardie ventriculaire rapide monomorphe.	802. Faux
803.	Le syndrome du QT long congénital est dû à des mutations dans les gènes des canaux Na ⁺ et K ⁺ .	803. Vrai
804.	La forme acquise du syndrome du QT long est beaucoup plus fréquente que la forme congénitale.	804. Vrai
805.	Le syndrome de QT long congénital est plus fréquent chez les hommes.	805. Faux
806.	La torsade de pointe peut induire une syncope ou dégénérer en fibrillation ventriculaire.	806. Vrai

807. Le syndrome du QT long congénital concerne généralement des patients jeunes (10-15 ans) en bonne santé avec un diagnostic erroné d'épilepsie ou de syncope vaso-vagale.	807. Vrai
808. La repolarisation est d'autant plus lente que le rythme cardiaque est lent.	808. Vrai
809. Les médicaments sont une cause majeure du syndrome de QT long acquis : antiarythmiques, antibiotiques, antifongiques, antidépresseurs, antipsychotiques, antinauséeux,...	809. Vrai
810. L'amiodarone est l'antiarythmique qui entraîne le plus souvent un syndrome du QT long acquis.	810. Faux
811. La procainamide utilisé dans le traitement de la TV peut induire un syndrome du QT long acquis.	811. Vrai
812. Les quinolones, l'azithromycine et le trimethoprim-sulfaméthoxazole entraînent un syndrome du QT long.	812. Faux
813. Les antifongiques causant un syndrome du QT long acquis sont surtout des échinocandines.	813. Faux
814. L'amytriptyline et l'imipramine sont des antidépresseurs causant un syndrome du QT long acquis.	814. Vrai
815. L'halopéridol, la chlorpromazine et le cisapride peuvent induire un syndrome du QT long acquis.	815. Vrai
816. L'hypermagnésémie et l'hypocalcémie favorisent le syndrome du QT long acquis.	816. Faux
817. Les AVC ischémiques ou hémorragiques favorisent le syndrome du QT long acquis.	817. Vrai
818. L'intervalle QT est corrigé par la FC en divisant la durée du QT par le temps entre deux ondes R.	818. Faux
819. L'ECG peut montrer des ondes T bifides ou alternantes en cas de syndrome du QT long.	819. Vrai

820. L'échographie cardiaque recherche une hypertrophie ventriculaire gauche en cas de syndrome du QT long.	820. Vrai
821. L'ECG montre une onde U et une tachycardie sinusale en cas de syndrome du QT long.	821. Faux
822. Le sulfate de magnésium est contre-indiquée dans le traitement du syndrome de QT long acquis en présence de taux sériques normaux de magnésium.	822. Faux
823. La sympathectomie cervico-thoracique est indiquée pour traiter un syndrome de QT long congénital.	823. Vrai
824. Le défibrillateur implantable est indiqué dans certains cas de syndrome du QT long congénital.	824. Vrai
825. Le maintien de la kaliémie >4,5mEq/L fait partie du traitement du syndrome du QT long acquis.	825. Vrai
826. 1 à 2g de sulfate de magnésium doivent être administrés en 20-30 minutes en cas de tachycardie ventriculaire non soutenue ou de torsades de pointe chez un patient atteint de syndrome du QT long acquis.	826. Faux
827. Les bêta-bloquants sont utilisés dans le traitement du syndrome de QT long acquis.	827. Faux
828. L'augmentation de la fréquence cardiaque est recommandée pour les arythmies résistantes au sulfate de magnésium en cas de syndrome du QT long acquis.	828. Vrai
829. L'hypertrophie ventriculaire gauche et l'insuffisance cardiaque prolongent le temps de repolarisation.	829. Vrai
830. La « torsade de pointe » est une tachycardie supra-ventriculaire rapide polymorphe.	830. Faux